

菌的后续作用可达数日,目前多主张对慢乙酰化者行 1 周 2 天间歇疗法;对快乙酰化者采用 1 天总量顿服或 2 天总量隔日顿服的给药法。间断疗法可以减少治愈所需药物总量,节省费用。

联合用药 临床上对严重感染,混合感染及为防止细菌产生耐药而常采用联合使用抗菌药物方案。结合 PAE 可重新评价联合用药的合理性,采用合理的联合用药方案时,PAE 可比单独使用时更长。例如:庆大霉素与青霉素,阿米卡星与哌拉西林联合用药后的 PAE 均呈协同作用,双氯西林在 2~4MIC 时与庆大霉素联用对金葡菌产生的 PAE 比单用时更长 1 小时以上,而头孢他啶与庆大霉素联用,其 PAE 与单用时相近或短于后者;对金葡菌,表皮葡萄球菌、绿脓假单胞菌及大

肠埃希菌,哌拉西林联用氧氟沙星的 PAE 比单用均有不同程序的延长,对大肠埃希菌尤为明显。与奈替米星联合 PAE(7~10 小时)比与庆大霉素联用 PAE(4~7 小时)要长,在高浓度时联合 PAE 更长,环丙沙星与庆大霉素对金葡菌、大肠埃希氏菌的 PAE 在不同浓度 (0.5~4MIC) 均呈相加作用,对铜绿假单胞菌在低浓度时联合 PAE 虽有所延长,但呈无关作用,随着试验浓度的增大,也有所延长,但呈无关作用,随着试验浓度的增大,也呈相加作用,试验表明,两药联合应用时,PAE 增长,抗菌作用增强,不仅为临床应用提供了依据,也对制定治疗方案具有实际指导意义。TMP 与庆大霉素、阿米卡星、妥布霉素联用,可使他们对肺炎克雷白杆菌的 PAE 显著延长,呈现相加、协同作用,并呈剂量依赖

性。应用 TMP 与氨基糖苷类抗生素的复方制剂不仅具有合理性,而且也应考虑 1 日 1 次给药方案。上述研究提示,氨基糖苷类抗生素同以上药物合用时,可适当延长各药的给药间隔时间。因其中氨基糖苷类抗生素潜在耳、肾毒性比较严重,故可采用 1 日 1 次或更长间隔的给药方案,既能维持疗效,又能减少氨基糖苷类在体内的蓄积,降低不良反应的发生。在氨基糖苷类药物的选择上,由于奈替米星比庆大霉素抗菌活性强,不良反应发生率低,同时与阿莫西林联合 PAE 更长,故两药联合为治疗严重感染的优化组合。

作者单位 413000 中南大学湘雅医学院益阳临床学院 湖南省益阳市中心医院

对降糖药有影响的药

吕 群

优降糖、达美康、克糖利等磺酰脲类口服药是目前常用的降糖药,有些复方降糖药也含有此类药物成分。应注意的是,在服用这类药物的同时服用其他某些药物,可产生相互影响,或是减少降糖作用,或是产生新的副作用,对此必须注意。

禁忌 磺酰脲类口服降糖药禁忌用于糖尿病性酮性酸中毒、重症感染、重度肝或肾功能障碍以及伴有严重外伤患者,因胰腺功能破坏或切除引起的继发性糖尿病患者也不能使用,对磺胺类和磺酰脲类药物过敏、急性代谢功能失调、孕妇、正在

使用肾上腺皮质激素以及经使用磺脲类药物治疗无效的患者都不能用此类药。

增强 有些药物可使磺脲类降糖药作用增强,有可能引起严重低血糖,因此与这类药物同时使用时应有医生指导,在密切监视血糖情况下可适当减少降糖药用量。这类药物包括:使磺酰脲类与蛋白质结合解离的药,包括阿司匹林、保泰松、磺胺增效剂、安妥明类及其衍生物类降脂药等;与磺酰脲类降糖药竞争酶类而影响降糖药代谢的药,如乙醇、华法令以及西米替丁等 H_2 受体拮抗剂等;影响磺酰脲类

从尿中排泄的药,如抗高尿酸血症药丙磺舒、别嘌呤醇等。

减弱 对于可使磺酰脲类降糖作用减弱的药物应尽可能不用,如医生认为必须使用时,则应由主治医师调整和掌握剂量。这类药物主要有:可明显促进降糖药代谢的药,如巴比妥酸盐、利福平;抑制胰岛素分泌的药,如噻嗪类利尿药、苯妥英钠及部分 β -受体阻滞剂;阻碍胰岛素作用的药物,如肾上腺皮质激素、生长激素、雌激素和儿茶酚胺等。 健卫工作室摘自 www.jkb.com.cn2002.11.07)

关注药物相互作用

孙成春

据某地一晚报道:一老年男性患者因感冒到省城某大医院就诊,结果该医院因用药失误加之抢救不力致使患者死亡。该患者因感冒就诊,医生(该院一位专家)给患者开了奥复沙星(氧氟沙星)和氨茶碱输液,输液半小时后,患者大汗淋漓、哮喘加重,2 小时后病情加重,口鼻出血,经抢救无效死亡。

这是一起典型的药物相互作用导致药物中毒的事件。氨茶碱是属于临床上必须进行血药浓度监测的药物之一,因为其安全范围比较窄,有效血药浓度范围为 10~20mg/L,低于此浓度疗效不明显,高于此浓度会出现恶心、呕吐、心律失常、惊厥甚至死亡等严重的毒副反应。氟喹诺酮类中不少药物可以抑制氨茶碱在肝脏的

代谢,使氨茶碱的血药浓度升高,从而导致不良反应的发生。这位患者就是因为氨茶碱血药浓度过高导致死亡的。遗憾的是,医生不了解这两种药物合并应用后可能产生的不良后果,也没有进行必要的氨茶碱血药浓度监测,更不可能及时调整氨茶碱的用量,从而导致了悲剧的发生。

在国内,治疗药物监测(TDM)工作已经

开展了近 20 年。TDM 是开展临床药学工作的重要手段,目前一些大医院大都配备了专门的仪器设备、实验室和人员来承担此项任务。主要是利用现代分析测试手段,对一些重点药物和重点病人进行血药浓度测定,并根据测定结果,调整用药剂量或给药间隔,设计个体化给药方案,做到合理用药。其中对治疗指数窄、毒副作用强的药物,以及合并用药后由于药物相互作用而引起药物的吸收、分布、代谢或排泄的改变而影响疗效时必须监测,以防止发生严重的不良反应。目前主要有十余

个品种被列为常规监测项目,主要有氨基糖苷类抗生素、万古霉素、地高辛、茶碱、利多卡因、苯妥英钠、卡马西平、丙戊酸、环孢素、FK506、氨甲蝶呤等。

但是,目前有能力进行 TDM 的医院主要集中在大中城市,大多数医院并没有药物监测,且有些仅仅是作为科研的内容,没有列入常规的监测项目中。许多医生认为凭经验用药即可,没有对药物不良相互作用是一种潜在的危险性引起应有的重视。实际情况是,临床上许多患者接受治疗时,常常联合应用两种或两种以上

的药物,因此可能会产生相互作用。目前,由药物相互作用带来的问题,特别是相互作用引起的不良反应,越来越受到医药人员及患者的关注。

当然,仅仅有关关注是不够的,还必需付诸行动,针对特殊和危重病人实施药理学监护,考虑到药物的潜在危险性,及时观察治疗。在有条件的地方应尽可能地进行血药浓度监测,及时调整药物剂量,以减少不良反应的发生。

(健卫工作室摘自 www.jkb.cn2002.12.19)

老年性痴呆的药物治疗

盛建华

常有老年性痴呆病人家属问我:“老年性痴呆有必要治疗吗?治疗有效吗?”我们医生的回答是肯定的:“需要治疗。”

虽然目前尚未找到治疗老年性痴呆的特效药,但已有大量的临床实践证明:对轻、中度痴呆患者,如能及时治疗,其记忆和生活能力都能得到不同程度的改善,治疗越早,疗效越好。而对晚期(病程达到 5~12 年)病人,则治疗较困难。

用于改善老年性痴呆病人记忆力和智力的药物统称为益智药。

益智药治疗老年性痴呆的目的为:①延缓或阻止痴呆程度的加重。②改善病人的记忆力。③抑制或逆转痴呆早期的关键性病理变化的发生。④提高痴呆病人的日常生活能力,改善生活质量。⑤减少并发

症,延长存活期。

近年来,医学界对老年性痴呆的治疗日趋重视,益智药有了很大发展,因其品种繁多,现按作用将其分为以下几类:

胆碱酯酶抑制剂 脑内有一种神经递质叫乙酰胆碱,它与学习和记忆关系密切,可被胆碱酯酶分解。胆碱酯酶抑制剂能抑制胆碱酯酶的活性,减少乙酰胆碱的分解,提高脑内乙酰胆碱的浓度,从而改善病人的记忆力和智力。现在这类药被认为老年性痴呆最主要的治疗药物,如目前国际上广泛使用的艾斯能等。

脑血管扩张剂:这类药能扩张脑血管,增加脑血流量,提高对脑细胞的供血供氧,多作为治疗老年痴呆的辅助用药。

促进脑细胞代谢药 这类药主要是促

进大脑细胞对氨基酸、磷脂及葡萄糖的利用,增强记忆力,增强病人的反应性和兴奋性,常用的有喜得镇等。

抗氧化剂 这类药可消除对细胞有损害作用的自由基,保护神经元,常用的有维生素 E 和维生素 C 等。

提高血氧浓度药物 这类药物提高血液携带氧的能力,提高血氧浓度,从而提高对脑细胞的供氧。

其他的辅助治疗药物,如一些中药。老年性痴呆的治疗是综合性的,患者一定要在“老年记忆障碍门诊”专科医生的指导下进行正规治疗。药物治疗是主要手段,但同时也应注意加强护理、心理调节等辅助措施。

(健卫工作室摘自 www.jkb.cn2002.12.11)

腹外疝三日疗法》、慢性鼻炎最新疗法学习班招生

山东省阳谷县疝气非手术治疗中心王学安主治医师利用国家高科技专利药物医用胶治疗除嵌顿疝以外的男女各种疝气、鞘膜积液,具有不开刀、不住院、痛苦小、疗效高、复发率低、不影响生育、操作简便、安全可靠、易于推广等特点,治疗 1 例病人仅需 15~30 分钟,是比较理想的治疗方法,尤适用于基层医院、卫生所。

王学安医师治疗男女各种疝气,是在“腹外疝注射疗法”的基础上逐步完善的,他把扎疝气带的保护时间从原来的 1~2 个月减少到 3 天,达到了国家医用胶的要求。同时,找到了女性疝外环口的确切位置,补充了股部、鞘膜积液的治疗,从而形成了自己独特的治疗方法,即腹外疝三日疗法(粘堵法)。《鲁西科技报》、《中国当代创业英才》、《世界优秀人才大典》、《中华成功人才大辞典》等报刊曾做过专题报道。其学术论文《T 胶治疗腹外疝 172 例疗效观察》、《T 胶治疗鞘膜积液 44 例疗效观察》、《腹外疝三日疗法治疗腹外疝 200 例远期疗效观察》。发表于《山东省医学论文总集》97 卷、98 卷,国际传统医学杂志。并授予山东省医学优秀论文证书和优秀科技成果奖、香港中英文对照海内外发行出版的大型医疗信息指南《中国知名专科医院》,对该中心颁发《中国知名专科医院》及“专科名医”荣誉证书。2002 年 5 月在北京第二届中华传统医学学术成果交流大会上,王学安、魏凤巧撰写的《腹外疝三日疗法(科峰医用胶)治疗腹外疝 500 例远期疗效观察》获论文一等奖,王学安医师获“弘扬中华文化”突出贡献奖(华伦杯)。

为了尽快推广这一新技术,我中心决定长期举办学习班,传授男女各种疝

气、鞘膜积液的非手术治疗技术及药物疝气带的治疗方法。学习方法采取面授与函授两种方式。面授班:以门诊学习为主,备有教材和实际操作录像带供学员观看学习,学期 5~7 天,每月 10 日开学,也可随到随学,学会为止。学习费、技术转让费、食宿费共计 800 元。函授班:邮寄教材及实际操作录像带或 VCD 光盘,也能达到同样效果,尤其适用于普外人员再学习,并免费咨询,函授费 350 元。科峰医用胶每盒 200 元/10 支,10 盒以上每盒 170 元,免费邮寄。

鼻炎专科 传授台湾许正吉教授发明的“鼻炎擦药契约疗法”,专治慢性单纯性鼻炎、慢性肥大性鼻炎、大部分过敏性鼻炎。不手术、不打针、不用激光,只在下鼻甲肥大处抹上 1 层药膏,10~15 分钟肥大的下鼻甲即萎缩消失,可以和病人签订无效退款协议,每月 15 日开学,学习时间 1~2 天,学费 300 元,安排住宿,生活费自理。为满足外地学员的需要,现已制成 VCD 光盘,主要介绍鼻炎擦药契约疗法(抹药法)及下鼻甲注射法。公开慢性鼻炎、过敏性鼻炎、副鼻窦炎的下鼻甲注射处方,函授费 300 元。

另外,传授水针刀治疗颈肩腰痛、骶管注射疗法治疗腰间盘脱出。腋臭(微创疗法)、慢性咽炎、慢性前列腺炎、颈淋巴结、胃病埋线、肛肠科治疗新技术,每项收费 100 元。代销肛肠用药,厂家直销电脑多功能射频痔疮治疗机,价格面议。

咨询汇款地址:山东省阳谷县金斗营乡王沙沃街里路北,邮编 252313,电话:0635)6885306、13863546217,联系人 王学安、魏凤巧